

TEMA 1.9 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Tumores de Partes Blandas

PERFIL EUNACOM 4.01.2.025

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

(Nota EUNACOM: La patología blanda tegumentaria se cruza muchas veces con diagnósticos dermatológicos u oncológicos puros. La nomenclatura del código respeta traumatismo/resolución en piel y partes blandas generales.)

Tumores de Partes Blandas

Las masas que se palpan debajo de la epidermis y transcurren por los compartimentos blandos pueden ser de origen epitelial orgánico o derivar intrínsecamente del tejido adiposo y fascial celular. Conocer su diagnóstico diferencial anatoclínico es básico para su derivación precoz.

1. Quiste Sebáceo (Quiste Epidérmico)

- **Fisiopatología:** Son lesiones cerradas revestidas por epitelio escamoso que producen una colección encapsulada de queratina descamada intraepidérmica y desechos (sebo). - **Clínica:** Presentación como nódulo superficial adherido a la propia epidermis de la piel. Característicamente poseen a simple vista un **poro negro central o "comedón"**, mediante el cual, de comprimirse intensamente, drena contenido sebáceo maloliente pastoso blanco amarillento. - **Tratamiento Piel Limpia:** Observación no intervencionista, es un elemento sumamente benigno. Eventualmente resección estética reglada si resulta inmensamente molesto o grande. - **Complicación Evolutiva:** Tienden clásicamente a superinfectarse y reventar formando micro-abscesos (*abscesos de quiste epidérmico*). - **Tratamiento Abscedado:** Drenaje simple más antibióticos cubriendo *Staphylococcus aureus* (Cefazolina o Cloxacilina empírica). - **Prevención de Recurrencias:** De presentar infecciones recidivantes periódicas severas, hay que esperar a que el proceso agudo "enfrie" y efectuar una extirpación de resección de la propia bolsa cápsular basal cutánea de manera definitiva.

2. Quiste Dermoides Curioso

- **Fisiopatología:** Fallas embrionarias mesodérmicas. - **Clínica Localizada Trascendente:** Nódulos lisos de similares apariencias a los quistes benignos pero con altísima localización patognomónica sugestiva. En la prueba teñirán firmemente un tumor en: 1. **La Cola o margen lateral de las Cejas Frontales**. 2. **Elevación central en el Piso de la Boca (línea media sublingual)**. - **Tratamiento:** Resumen en simples observaciones no oncológicas a menos que se sobre dimensionen en áreas estéticas de alta deformidad facial en cuyo caso requieren cirugía excisional obligada.

3. Lipoma

- **Clínica General:** Tumor benigno graso. Masa nodular blanda subcutánea indolora (más blando que la tensión de un músculo

Tratamiento Multidisciplinario Oncológico: Todo sarcoma va encauzado a pabellón en primer enfoque más **Quimioterapia y Radioterapia masiva acompañante pre o pos cirugica**.

- **Cirugías Conservadoras (Sarcomectomías Oncológicas):** Preservan extremidad si el tumor respeta vasculatura masiva y la irradiación neoadyuvante achicó grandemente el estadio previo.

- **Cirugías Radicales Masivas:** La última alternativa si no responden a Quimioterapias y si el tumor absorbió los troncos nervo-musculares y los vasos mayores con la incesante necesidad de extirpar y **amputar** a nivel axilar o femoral a la extremidad integral en pos de pervivencia.

Factor Pronóstico de Sobrevida Oncológica: Condicionado fuertemente no solo al tamaño primario sino al **Grado de Diferenciación Histológica tumoral** (Gradación de malignidad G1 a G3, siendo los G3 los altamente indiferenciados y letales absolutos).

esquelético). - **Semiotecnia Palpatoria:** El nódulo posee alta fijeza hacia los planos musculares basales inferiores pero **la piel suprayacente corre y se desliza con infinita movilidad normal por encima del tumor graso**. - **Epidemiología Estructural:** La gran mayoría son asintomáticos estacionarios que no logran superar los **5 cm de diámetro**. - **Diagnóstico:** Clínico puro semiológico. Únicamente se apoya en Ecografía Subcutánea de partes blandas si el tumor está muy tenso y simula sospecha ambigua de sarcomas o quistes masivos duros. - **Tratamiento y pronóstico:** Observación. Son procesos neoplásicos adiposos benignos. - **Criterios de Derivación Resectiva (Biopsia Excisional en Pabellón):** - Masas grasas que repentinamente ganen un veloz crecimiento celular masivo inestable. - El nódulo en reposo excede por regla los 5 cm longitudinales (sospecha inicial de sarcoma subyacente).

4. Sarcoma de Partes Blandas

Representan el temido tumor maligno mesenquimático por antonomasia de los tejidos adiposos (liposarcoma) o musculares estriados (rhabdomyosarcoma).

- **Clínica de la Masa:** Tumor que se palpa netamente indurado y firme.
- - Crecimiento acelerado altísimo con dimensiones que alcanzan abultamientos feroces gigantesco intraparietales en una cuantas semanas (10, a veces más de 15 o 20 cm).
- - **Diferencia con lipoma a la Inspección Palpatoria:** La masa maligna fija tanto en profundidad inferior basal **como también se adhiere y retrae la piel y dermis superficial superpuesta inmovilizándola**.
- **Diagnóstico:**
- 1. **Imágenes Primer Paso: Resonancia Magnética Nuclear (RMN)** del segmento u área. Es el estudio Gold Standard pre-operativo EUNACOM para tumores blandos extensos y fijar el límite neoplásico perimetral anatómico. (En su gran defecto extremo de ausencia de equipo RM, una Ecografía es la única alternativa para medir tamaño de partes blandas groseras).
- 2. **Confirmación Etapificadora:** Biopsia "Core" o de Punción Tru-cut obligada por oncólogo.

• ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Principio de Biopsias en Sarcoma: La incisión de la aguja con la que perforó al sacar el tejido del tumor "siembra" células tumorales mortales a través del recorrido intraparietal cutáneo de regreso. Al minuto del pabellón post, el cirujano *siempre* deberá ampliar los márgenes y eliminar y enjear todo ese trayecto quirúrgico punzado para erradicar siembras distales recurrentes locales.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente de cuarenta y cinco años consulta por un aumento de volumen en el muslo derecho de doce centímetros de diámetro, de rápido crecimiento, consistencia muscular, adherido a planos profundos. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tumores de Partes Blandas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El quiste sebáceo o epidérmico es benigno, con poro central que exuda sebo; se observa si está asintomático, se reseca si es grande, se drena más antibióticos si se infecta.
- El quiste dermoide tiene ubicaciones características: cola de la ceja y piso de la boca; se observa o se reseca si es grande o deformante.
- El lipoma menor de cinco centímetros se observa; si mide más de cinco centímetros o crece rápido se reseca por sospecha de sarcoma.
- El sarcoma de partes blandas crece rápido, puede superar los diez centímetros y tiene consistencia muscular; el diagnóstico de elección es la resonancia magnética nuclear.
- La biopsia del sarcoma es histológica por punción; al operar hay que resecar el trayecto de la aguja para evitar siembra tumoral.
- El tratamiento del sarcoma es cirugía más quimioterapia y radioterapia; si es muy grande se hace quimiorradiación preoperatoria para achicar y salvar la extremidad.
- El factor pronóstico más importante del sarcoma es el grado histológico: G1 mejor pronóstico, G3 peor pronóstico.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TUMORES DE PARTES BLANDAS)**PREGUNTA 1**

Un paciente de cuarenta y cinco años consulta por un aumento de volumen en el muslo derecho de doce centímetros de diámetro, de rápido crecimiento, consistencia muscular, adherido a planos profundos. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico?

- A)** Ecografía de partes blandas
- B)** TAC con contraste
- C)** Resonancia magnética nuclear
- D)** Biopsia incisional directa sin imagen previa
- E)** Radiografía simple del muslo

PREGUNTA 2

Un hombre de treinta y cinco años consulta por un nódulo subcutáneo en la espalda de tres centímetros, blando, móvil, con piel suprayacente normal y sin cambios en seis meses. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A)** Sarcoma, resonancia magnética urgente
- B)** Lipoma, observación
- C)** Lipoma, resección quirúrgica inmediata
- D)** Quiste sebáceo, incisión y drenaje
- E)** Quiste dermoide, resección electiva

PREGUNTA 3

Un paciente con sarcoma de partes blandas de veinte centímetros en el muslo va a ser operado. ¿Cuál es la estrategia terapéutica más adecuada?

- A)** Amputación directa sin tratamiento previo
- B)** Solo cirugía sin quimioterapia ni radioterapia
- C)** Quimioirradiación preoperatoria para achicar el tumor y luego cirugía conservadora
- D)** Solo radioterapia sin cirugía por el riesgo de amputación
- E)** Quimioterapia postoperatoria sin cirugía previa

RESUMEN: TUMORES DE PARTES BLANDAS

Los tumores de partes blandas benignos incluyen el quiste sebáceo o epidérmico, el quiste dermoide y el lipoma. El quiste sebáceo es una neoplasia benigna de la piel, móvil, con poro central que exuda sebo. Se observa si es asintomático; se reseca si es grande o molesto. Si se infecta, se trata con antibióticos antiestafilocócicos más incisión y drenaje. El quiste dermoide es similar pero tiene ubicaciones características: cola de la ceja y piso de la boca. El lipoma es un tumor de consistencia blanda, adherido a planos profundos pero con piel móvil. Si mide menos de cinco centímetros se observa; si es mayor de cinco centímetros se reseca por sospecha de sarcoma. El sarcoma de partes blandas es maligno y crece rápidamente, alcanzando más de diez centímetros, con consistencia muscular, adherido a planos profundos y puede adherirse a la piel. El diagnóstico de elección es la resonancia magnética nuclear. Luego se realiza biopsia histológica por punción, resecando el trayecto de la aguja al operar. El tratamiento es cirugía más quimioterapia y radioterapia. Si el tumor es muy grande y hay intención de salvar la extremidad, se hace quimioirradiación preoperatoria para achicarlo antes de la cirugía. El factor pronóstico más importante es el grado de diferenciación histológica, siendo el G3 el más indiferenciado y de peor pronóstico.